

Réanimation 2

Site: [Moodle Université de Genève](#)
Cours: Compétences cliniques en 2e année Bachelor
Livre: Réanimation 2

Imprimé par: Damien Fulliquet
Date: jeudi 8 mai 2025, 11:34

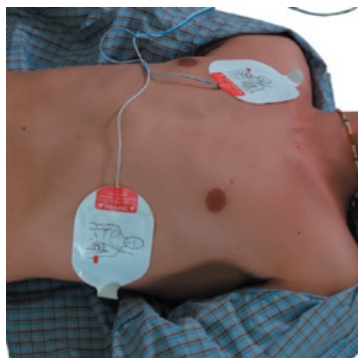
2. Contenu

Séquence de Réanimation (rappel)

[Algorithme BLS-AED-SRC 2021](#)

Eléments spécifiques à ce séminaire

D – Défibrillation avec défibrillateur semi automatique (DSA)



Procédure :

1. Continuer la RCP jusqu'à ce que le défibrillateur soit prêt.
2. Allumer le défibrillateur. Ceci permet d'initier le guide vocal et/ou textuel.
3. Appliquer les électrodes sur le thorax de la victime. La première électrode doit être placée sur le bord supéro-externe droit du sternum, juste au-dessous de la clavicule droite. La deuxième électrode est placée latéralement au mamelon gauche, environ 7 cm en dessous du creux axillaire. Un schéma est généralement disponible.
4. Le défibrillateur procède automatiquement à l'analyse du rythme. Ne pas toucher la victime pendant l'analyse afin d'éviter les artéfacts. Si le patient est en FV/TV, l'appareil annonce un message texte ou vocal indiquant le choc.
5. Avant de choquer, veiller à ce que personne ne soit en contact avec la victime (« Attention choc! »)

Commentaires

Certains DSA disposent d'un écran permettant de visualiser le rythme. Dans ce cas :

1. Ne pas perdre de temps à tenter de reconnaître le rythme
2. Se fier à l'analyse et aux consignes du DSA

La première défibrillation a lieu dès que le DSA est disponible. **Après chaque défibrillation, reprise immédiate de la RCP, en commençant par les compressions thoraciques, sans essayer de prendre le pouls.** Le contrôle du rythme et de pouls (si la défibrillation a été efficace) a lieu seulement après 2 minutes (environ 5 cycles de RCP), au moment où le DSA vous l'indique.

Dans plus de 85% des cas, le premier choc termine une fibrillation ventriculaire.

Les DSA sont les plus courants aux HUG et dans les espaces publics. Ils n'offrent pas le choix de l'énergie à délivrer.

Occasionnellement, des défibrillateurs plus complexes que ceux présentés dans ce séminaire peuvent être disponibles dans les hôpitaux. Le maniement de ces appareils est hors du champ de ce séminaire, mais quelques éléments peuvent toutefois être mentionnés :

1. Avec les défibrillateurs monophasiques, il faut toujours défibriller avec une énergie de 360J (énergie maximale).
2. Si on ne connaît pas la forme de l'onde du défibrillateur biphasique ou en l'absence de données techniques, toujours choisir l'énergie maximale (généralement 200J).

Poursuite de la RCP



Procédure

1. Après délivrance du choc, reprendre immédiatement la RCP pour 5 cycles en commençant par les compressions thoraciques.
2. Poursuivre la réanimation jusqu'à ce que des secouristes professionnels prennent la relève ou que le patient bouge.

Mise en position latérale de sécurité (PLS)

La mise en PLS est réservée aux patients comateux **non traumatisés, présentant des signes de vie et dont la respiration spontanée est assurée.**

Les patients présentant un **coma d'origine traumatique ne doivent pas être mobilisés** avant l'arrivée des secours professionnels.



S'agenouiller à une distance adéquate (20 à 30 cm) au côté du patient et éloigner tout objet pouvant interférer avec la mise en PLS.

Positionner le bras le plus proche de vous à angle droit par rapport au corps de la victime. Le coude droit doit être plié, et la paume de la main doit être positionnée vers le haut.



Ramenez le bras distant vers vous, le coude plié, en positionnant le dos de la main du patient face à la joue se trouvant le plus près de vous.



Tout en maintenant la position précédente, utilisez votre autre main pour fléchir le genou de la jambe se trouvant le plus loin de vous. Le pied du patient doit rester sur le sol.



En conservant la position précédente, tournez le patient face à vous. Le mouvement doit être bref, précis et coordonné entre les deux mains. Les genoux du sauveteur empêchent la poursuite du mouvement.

Basculez légèrement la tête en arrière afin de libérer les voies aériennes.

Le visage du patient devrait faire face au sol afin de permettre un éventuel écoulement de liquide(s).

Le patient doit rester sous surveillance permanente.